

## **(P. del S. 207)**

### **LEY**

Para crear la “Ley de Manejo de Estudiantes con Dermatitis Atópica en las Escuelas Públicas y Privadas”, a fin de establecer el procedimiento a seguir en las aulas para el manejo, acomodados y tratamiento adecuado de los estudiantes con dermatitis atópica; prohibir el discrimen por razón de su condición médica; y para otros fines relacionados.

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica, inflamatoria y de naturaleza autoinmune que afecta principalmente la piel. Aunque puede presentarse en personas de cualquier edad, es más frecuente en la población infantil. La cantidad de personas diagnosticadas anualmente va en aumento constante a nivel mundial, incluyendo Puerto Rico. Se estima que entre el 10% y el 30% de los niños, y entre el 2% y el 10% de los adultos padecen de esta condición. En niños de 6 a 7 años, su prevalencia alcanza el 24.8%.

Esta enfermedad tiene un componente genético y afecta las células inmunológicas conocidas como linfocitos TH2. Cuando estos linfocitos se desregulan, liberan proteínas que atacan la piel, provocando el cuadro inflamatorio característico de la dermatitis atópica. Estas proteínas inducen una intensa inflamación y edema cutáneo, lo que comúnmente se conoce como eccema atópico.

La dermatitis atópica es considerada un trastorno multisistémico, ya que, además de comprometer la piel, puede estar asociada con otras condiciones como asma bronquial, sinusitis, rinitis alérgica, afecciones oftálmicas e incluso trastornos conductuales. Las manifestaciones pueden heredarse en distintos grados de severidad: leve, moderada o severa. Asimismo, factores ambientales pueden desencadenar brotes o recaídas. En Puerto Rico, la incidencia es elevada debido a elementos como hongos, polen y el polvo del Sahara.

Esta condición suele comenzar en niños de dos (2) meses de edad. Es más común durante la niñez y tiende a mejorar en la adolescencia. Sin embargo, si persiste o se desarrolla posteriormente, puede volverse más severa y crónica. El manejo adecuado de los pacientes requiere un equipo médico multidisciplinario que incluya dermatólogos, pediatras, alergistas, neumólogos y psicólogos, entre otros. En la actualidad, los avances farmacológicos han mejorado significativamente el tratamiento de esta enfermedad. Un estudio realizado en Puerto Rico sobre la prevalencia de la dermatitis atópica en niños de edad escolar mostró evidencia de un problema de salud pública, ya que el setenta por ciento (70%) de los casos no han sido diagnosticados, lo que demuestra un problema de salud pública.

La dermatitis atópica resulta de una interacción compleja entre diversos factores.

Los principales elementos implicados en su fisiopatología incluyen predisposición genética, disfunción epidermal, exposición a factores ambientales desencadenantes, alteraciones en la microbiota cutánea y trastornos del sistema inmunológico. Las personas que padecen formas graves de la enfermedad tienen mayor riesgo de desarrollar múltiples enfermedades autoinmunes, según un estudio publicado en el *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. También presentan una alta incidencia de asma o de rinitis alérgica como condiciones comórbidas.

Durante los brotes, los pacientes experimentan síntomas como picor intenso, resequedad, ampollas, exudación, costras y descamación. Estos síntomas pueden alterar el sueño, dificultar las rutinas diarias, causar dolor, e incluso derivar en infecciones cutáneas. La falta de sueño y el picor constante afectan la concentración, lo que repercute negativamente en el desempeño escolar de los niños.

Vivir con dermatitis atópica representa un reto, especialmente para los niños que no reciben el cuidado adecuado en las escuelas. El tratamiento necesario para controlar esta condición, que afecta el órgano más grande del cuerpo, complica la participación de los estudiantes en actividades curriculares y extracurriculares. Dado que los niños pasan gran parte del día en la escuela, es fundamental que puedan continuar sus tratamientos durante ese tiempo para evitar complicaciones a corto y largo plazo. De lo contrario, estarían expuestos a desarrollar problemas de salud adicionales como alergias alimentarias, queratocono, ictiosis, ansiedad, depresión y trastornos del sueño, afectando así su rendimiento académico en su rendimiento académico.

Finalmente, los pacientes con dermatitis atópica hacen un uso elevado de los recursos del sistema de salud, lo que representa un costo significativo. A pesar de su alta prevalencia, diversos estudios han evidenciado un bajo nivel de diagnóstico y tratamiento adecuado, lo que refuerza su carácter de problema de salud pública en el país.

## **DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

### **Artículo 1.- Título.**

Esta Ley se conocerá como “Ley de Manejo de Estudiantes con Dermatitis Atópica en las Escuelas Públicas y Privadas”.

### **Artículo 2.- Declaración de política pública.**

La dignidad e igualdad de los seres humanos son principios fundamentales consagrados en la Constitución de Puerto Rico y rigen el sistema social, legal y gubernativo. En virtud de estos principios, el Gobierno reconoce su responsabilidad de establecer condiciones adecuadas que promuevan el bienestar de las personas con impedimentos o enfermedades, garantizando que disfruten de una vida plena, el ejercicio de sus derechos y la protección contra cualquier tipo de discriminación.

A tales efectos, se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar a los estudiantes que padecen dermatitis atópica el manejo, acomodo y tratamiento adecuado

de su condición en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Asimismo, se prohíbe el discrimen por razón de dicha enfermedad.

Con el fin de garantizar una atención integral a los estudiantes que padecen dermatitis atópica, se reconoce la importancia de integrar esfuerzos multisectoriales en el abordaje de esta condición. A tales efectos, el Departamento de Educación, en coordinación con el Departamento de Salud y otras entidades pertinentes, deberá establecer protocolos escolares que contemplen el apoyo psicológico individual y grupal, la educación dirigida a la comunidad escolar sobre la dermatitis atópica, y estrategias de intervención que promuevan el bienestar emocional y físico de los estudiantes. Asimismo, se fomentará la capacitación del personal docente y administrativo en el manejo adecuado de esta condición, y se promoverán alianzas con organizaciones especializadas para el desarrollo de programas educativos y de apoyo.

#### Artículo 3.- Definiciones.

(a) Dermatitis Atópica: trastorno cutáneo inflamatorio crónico y recidivante, con una patogenia compleja que involucra susceptibilidad genética, disfunción de la barrera inmunitaria y epidérmica, y factores ambientales.

(b) Diagnóstico médico de dermatitis atópica: documento emitido por el proveedor de salud que atiende al estudiante, en el cual se detalla el diagnóstico, tratamiento médico relacionado con la dermatitis atópica y las necesidades específicas del estudiante.

(c) Estudiante: todo niño(a) diagnosticado con dermatitis atópica y debidamente matriculado en una escuela pública o privada.

(d) Institución educativa: toda institución educativa a nivel maternal, pre-escolar, elemental, intermedia y superior, pública o privada, que provea servicios educativos.

(e) Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica: documento escrito, redactado, firmado y aprobado por el/la director(a) escolar y los padres, encargados o tutores legales del estudiante, que incluirá los acomodos razonables necesarios en el ámbito académico, físico y emocional, incluyendo acceso a tratamiento médico, apoyo psicológico y ajustes en actividades escolares.

(f) Reunión escolar: encuentro solicitado por los padres, encargados o tutores legales para notificar la condición del estudiante y coordinar la redacción y ejecución del Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica.

#### Artículo 4.- Prohibición de discrimen.

Se prohíbe toda forma de discriminación por razón de la condición de dermatitis atópica. Todo estudiante diagnosticado y matriculado en una institución educativa tendrá derecho a la participación plena en las actividades del plantel escolar, tanto curriculares como extracurriculares. Para ello, se le garantizarán los acomodos necesarios para el manejo adecuado de su condición, conforme a lo establecido en esta Ley.

#### Artículo 5.- Obligaciones de las instituciones educativas.

La institución escolar estará obligada a realizar todas las gestiones necesarias para asistir al estudiante y cumplir con el Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica. Asimismo, deberán coordinar con profesionales de la salud, incluyendo psicólogos escolares, para atender las necesidades emocionales y conductuales del estudiante. También, deberán facilitar espacios adecuados para la administración de tratamientos médicos durante el horario escolar. Además, se promoverán campañas educativas dirigidas a la comunidad escolar sobre la dermatitis atópica, en colaboración con otras organizaciones.

#### Artículo 6.- Deberes de los padres, encargados o tutores.

Los padres, encargados o tutores de un estudiante con dermatitis atópica notificarán al(a la) director(a) de la escuela que su hijo padece de la condición y solicitarán una reunión al inicio del año escolar, o en cualquier momento que sea necesario, si el diagnóstico ocurre durante el semestre escolar. Esta reunión tendrá como fin la redacción del Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica y deberá celebrarse no más tarde de diez (10) días naturales contados a partir de la solicitud.

Asimismo, los padres, encargados o tutores legales deberán entregar al (a la) director(a) escolar copia del Diagnóstico Médico de Dermatitis Atópica, el cual incluirá instrucciones escritas del proveedor de salud respecto a, pero sin limitarse:

- (a) nivel de automanejo del estudiante con relación a sus cuidados,
- (b) síntomas y tratamiento de acuerdo con la intensidad leve, moderada y severa,
- (c) administración de medicamentos en caso de emergencia.

#### Artículo 7- Redacción del Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica.

El(La) director(a) escolar redactará, junto con los padres, encargados o tutores y el personal de enfermería escolar, de estar disponible, el Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica del estudiante, conforme a las indicaciones contenidas en el diagnóstico médico. Este plan será redactado y firmado no más tarde los quince (15) días naturales luego de celebrada la reunión escolar.

#### Artículo 8.- Monitoreo de la condición.

Se permitirá al estudiante realizar el monitoreo de su piel y la administración de medicamentos en el lugar de la institución escolar de su preferencia. No se le impondrá un lugar específico para ello.

#### Artículo 9. - Contenido del plan.

El Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica será individualizado y deberá atender las necesidades particulares de cada estudiante. Incluirá, pero no se limitará a, los siguientes elementos:

(a) Nombre del estudiante, año escolar, grado que cursa, nombre del maestro de salón hogar y del director escolar.

(b) Nivel de autocuidado del estudiante, según lo establecido por su proveedor de salud en el Plan Médico de Manejo de Dermatitis Atópica y lugar donde se guardarán los medicamentos del estudiante.

(c) Disposiciones relacionadas con:

(1) Uniforme: se permitirá al estudiante utilizar vestimenta distinta al uniforme escolar en caso de brote o cuando así lo indique su proveedor de salud.

(2) Ejercicios y actividades físicas: El estudiante podrá participar en actividades deportivas conforme a su plan médico. En caso de brote o malestar, se le excusará sin amonestación.

(3) Acceso al baño y agua: le será permitido al estudiante tomar agua e ir al baño, sin restricción alguna.

(4) Monitoreo de brotes y administración de medicamentos: se establecerá el nivel de autocuidado, los síntomas habituales, tratamientos y el protocolo ante exacerbaciones.

(5) Excursiones y otras actividades extracurriculares: el estudiante podrá participar sin restricciones, y se realizarán los acomodos necesarios.

(6) Trabajo escolar y exámenes: se garantizarán acomodos razonables. Si el estudiante presenta un brote antes o durante una evaluación, se le repondrá sin sanción. También se le otorgará tiempo adicional si necesita pausas para medicarse, hidratarse o ir al baño. Las ausencias o tardanzas relacionadas con su condición no serán sancionadas.

(7) Comunicaciones: se establecerá un canal de comunicación con los padres, encargados o tutores legales del estudiante sobre todo cambio en las actividades escolares.

(8) Aviso a los padres: se indicará cuándo y cómo la institución deberá comunicarse con los padres, incluyendo contactos de emergencia.

(9) Aprobación y firma: el Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica será aprobado y firmado por el(la) director(a) escolar, el(la) padre/madre, encargado o tutor y el personal escolar entrenado.

Una vez firmado el Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica, el(la) director(a) entregará copia del mismo al padre, encargado o tutor del estudiante, y al personal escolar entrenado. El original se archivará en el expediente del estudiante. Este Plan Escolar deberá ser revisado por lo menos una vez al año, sin perjuicio de que pueda ser enmendado en cualquier momento si surgen nuevas necesidades o cambios en el tratamiento, previa solicitud y reunión correspondiente.

Artículo 10. - Exclusiones.

La institución escolar proveerá al estudiante un lugar adecuado y seguro para guardar los medicamentos. No obstante, la escuela no está obligada a proveer nevera. Todos los medicamentos y meriendas necesarias para el manejo de la dermatitis atópica del estudiante serán responsabilidad de los padres, encargados o tutores del estudiante. La institución escolar no será civilmente responsable por pérdida o daño de dichos artículos, siempre que estos hayan actuado con la debida diligencia.

#### Artículo 11.- Prohibición de cargos monetarios.

Se prohíbe a la institución educativa imponer cargo monetario alguno a los padres, encargados o tutores para el cumplimiento de esta Ley. Cualquier cobro constituirá un acto de discrimen conforme a lo aquí dispuesto.

#### Artículo 12.- Deber de confidencialidad.

La institución educativa mantendrá en estricta confidencialidad todos los documentos relacionados a la condición médica del estudiante, salvo para informar a los maestros y personal pertinente sobre los acomodos razonables necesarios. Los padres, encargados o tutores legales podrán renunciar a este derecho de confidencialidad mediante declaración expresa en el Plan Escolar de Manejo de Dermatitis Atópica del estudiante.

#### Artículo 13.- Acciones por discrimen; legitimación.

Todo estudiante que sea objeto de discrimen por su condición de dermatitis atópica podrá presentar una acción de daños y perjuicios contra cualquier persona natural o jurídica responsable. Si el estudiante no puede ejercer dicha acción, podrá hacerlo su padre, madre, padre, encargado, tutor, heredero o causahabiente. El término prescriptivo será de un (1) año a partir del conocimiento del acto discriminatorio.

#### Artículo 14. - Indemnización.

La persona demandada que resulte responsable mediante sentencia final y firme deberá pagar una indemnización por los daños causados.

#### Artículo 15. - Separabilidad.

Si cualquier disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o nula por un tribunal competente, dicha declaración no afectará, menoscabará o invalidará las disposiciones restantes de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la parte específica de que se trate.

Artículo 16. - Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.